BAİBÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ · HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Omaha Sistemi Çalışma Notu

Problem Sınıflama Şeması · Girişim Şeması · Problem Değerlendirme Ölçeği · Doldurulmuş Örnekler

FR.186 madde 14 ve 19 ile FR.184 beceri 9 için: problemin tanımı, hedef ve kategoriler, girişimler ve Bilgi-Davranış-Durum değerlendirmesi adım adım.

İçindekiler

Halk Sağlığı Hemşireliği – Omaha Sistemi Çalışma Notu

1. Omaha sistemi nedir?

1.1 Üç bileşen ve hemşirelik süreciyle ilişkisi

2. BİRİNCİ BİLEŞEN: PROBLEM SINIFLAMA ŞEMASI

2.1 Dört alan ve 42 problem

2.2 Hangi problemi seçeceğime nasıl karar veririm?

2.3 Niteleyiciler (modifier)

2.4 Belirti/bulgular ve risk faktörleri

3. İKİNCİ BİLEŞEN: GİRİŞİM ŞEMASI

3.1 Dört kategori

3.2 Hedefler – halk sağlığında sık kullanılanlar

3.3 Bireye özgü bilgi

4. ÜÇÜNCÜ BİLEŞEN: PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

4.1 Bilgi

4.2 Davranış

4.3 Durum

4.4 Ne zaman puanlanır?

5. ADIM ADIM OMAHA KAYDI NASIL YAPILIR?

6. DOLDURULMUŞ ÖRNEKLER

6.1 ASM – Kanser tarama eğitimi (KKMM ve mamografi)

6.2 ASM – Hipertansiyonu olan yetişkin

6.3 Okul – İlkokul sınıfında el hijyeni (toplum düzeyi)

6.4 Lohusa izlemi – Emzirmede güçlük

6.5 Ev ziyareti – Yaşlıda düşme riski

6.6 ASM – Sigara içen gebe

6.7 Okul – Öğretmenlerde ses sağlığı ve stres (toplum düzeyi)

7. SIK YAPILAN OMAHA HATALARI

8. OMAHA İLE NANDA ARASINDAKİ FARK

9. KENDİNİ TEST ET

Halk Sağlığı Hemşireliği – Omaha Sistemi Çalışma Notu

Omaha sistemi değerlendirme formlarında üç ayrı yerde puanlanır:

- **FR.184 beceri 9:** "Sağlık eğitimleri ve ASM hemşirelik uygulamaları sırasında **OMAHA sınıflama sistemini kullanabilme**"
- **FR.186 madde 14 (ASM – 8 puan):** "Eğitimlerde Omaha sınıflama sistemini kullanma (**Omaha sınıflama listesi ile problemin tanımı, hedef ve kategoriler, hemşirelik girişimleri ve girişimler ile problemin değerlendirilmesi**)"
- **FR.186 madde 19 (Okul – 5 puan):** Aynı ifade, okul eğitimleri için.

FR.186'daki tanım, her eğitim ya da izlem için ne yazman gerektiğini açıkça söyler: **(1) problemin tanımı → (2) hedef ve kategoriler (girişimler) → (3) problemin değerlendirilmesi.** Bu not, bu üç adımı nasıl yapacağını, Omaha'nın tüm bileşenlerini ve doldurulmuş örnekleri anlatır.

---

1. Omaha sistemi nedir?

Omaha sistemi, ABD'de **Omaha Ziyaretçi Hemşireler Derneği** tarafından, ev ziyaretleri ve toplum sağlığı hizmetlerinde hemşirelerin yaptıklarını **standart bir dille** tanımlamak ve kaydetmek için geliştirilmiş, araştırmalarla test edilmiş bir **sınıflama sistemidir**. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olup ülkemizde halk sağlığı hemşireliği eğitiminde ve araştırmalarında yaygın olarak kullanılır.

Neden halk sağlığında kullanılır?

- **Birey, aile ve toplum** düzeyinde kullanılabilir; ev, ASM, okul, işyeri, huzurevi gibi her ortama uygundur.
- Hastalığı değil, bireyin **sağlıkla ilgili sorunlarını, risklerini ve sağlığı geliştirme isteğini** tanımlar; yani hem hasta hem sağlıklı bireyler için uygundur.
- Hemşirenin yaptığı **eğitim, izlem, yönlendirme ve uygulamaları** sistemli olarak kaydeder.
- **Sonuçları sayısal olarak ölçer** (Bilgi-Davranış-Durum puanları); böylece eğitimin ve bakımın işe yarayıp yaramadığı gösterilebilir.

1.1 Üç bileşen ve hemşirelik süreciyle ilişkisi

Omaha sistemi birbirine bağlı üç bileşenden oluşur:

1. **Problem Sınıflama Şeması:** Bireyin/ailenin/toplumun sağlık sorunlarını tanımlar. Hemşirelik sürecindeki **veri toplama ve tanılama** basamağına karşılık gelir.
2. **Girişim Şeması:** Hemşirenin bu sorunlara yönelik ne yaptığını tanımlar. Hemşirelik sürecindeki **planlama ve uygulama** basamağına karşılık gelir.
3. **Problem Değerlendirme Ölçeği (Sonuçlar İçin):** Sorunun bilgi, davranış ve durum boyutlarında nasıl değiştiğini ölçer. Hemşirelik sürecindeki **değerlendirme** basamağına karşılık gelir. Bu ölçek bakımın başında da uygulanır (başlangıç puanı).

Kısaca: **Problem → Girişim → Değerlendirme.**

---

2. BİRİNCİ BİLEŞEN: PROBLEM SINIFLAMA ŞEMASI

Problem sınıflama şeması dört düzeyden oluşur: **alanlar → problemler → niteleyiciler → belirti/bulgular (ya da risk faktörleri).**

2.1 Dört alan ve 42 problem

Problemler **4 alan** altında toplanır; toplam **42 problem** vardır. Kolay ezber: **4 – 12 – 18 – 8.**

Çevresel alan (4 problem)

Bireyin, ailenin ya da toplumun içinde yaşadığı **fiziksel ortam ve maddi kaynaklar**.

- **Gelir:** Yaşamsal gereksinimleri karşılamaya yetecek gelirin olmaması ya da gelirin yönetilememesi. *Örnek:* Yaşlının ilaç ve ısınma giderlerini karşılayamaması.
- **Sanitasyon (temizlik/hijyenik koşullar):** Ortamın temizliği, su, atık, haşere, gıda hijyeni. *Örnek:* Okul tuvaletlerinde sabun olmaması, evde haşere, güvenli olmayan içme suyu.
- **Konut (yaşam alanı):** Evin yapısal güvenliği ve uygunluğu: ısınma, nem, kalabalık, kaygan zemin, aydınlatma, merdivenler, tehlikeli maddelerin saklanması. *Örnek:* Yaşlının evinde kaygan halılar ve aydınlatma eksikliği; bebeğin ulaşabileceği yerde ilaçlar.
- **Komşuluk/işyeri güvenliği:** Çevrede ya da işyerinde suç, şiddet, trafik, fiziksel tehlikeler, kirlilik. *Örnek:* Okul önünde yaya geçidi olmaması; fabrikada gürültü ve korunmasız makineler.

Psikososyal alan (12 problem)

Davranış, duygu, iletişim, ilişkiler ve gelişim örüntüleri.

- **Toplumsal kaynaklarla iletişim:** Sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşmada, bunları kullanmada güçlük (dil engeli, hizmetten haberi olmama, ulaşım). *Örnek:* Göçmen ailenin ASM hizmetlerinden haberi olmaması.
- **Sosyal ilişki (sosyal temas):** Sosyal etkileşimin azlığı, yalnızlık. *Örnek:* Evden çıkmayan yalnız yaşlı.
- **Rol değişikliği:** Yeni rollere uyum (ebeveyn olma, emeklilik, dul kalma, bakım veren olma). *Örnek:* İlk kez anne olan kadının yeni rolüne uyumda güçlük.
- **Kişilerarası ilişki:** Aile üyeleri, eşler, akranlar arasındaki ilişki sorunları, çatışma. *Örnek:* Akran zorbalığı; eşler arasında sürekli çatışma.
- **Maneviyat (spiritüel durum):** İnanç ve değerlerle ilgili sıkıntılar, sağlık bakımıyla çatışan inançlar.
- **Yas:** Kayıp sonrası tepkiler ve baş etme güçlüğü.
- **Ruh sağlığı:** Üzüntü, umutsuzluk, kaygı, depresyon belirtileri, intihar düşüncesi. *Örnek:* Doğum sonu depresyon belirtileri; sınav kaygısı yaşayan ergen; tükenmişlik yaşayan öğretmen.
- **Cinsellik:** Cinsel sağlıkla ilgili kaygılar ve güçlükler.
- **Bakım verme/ebeveynlik:** Bir çocuğa ya da bakıma muhtaç birine bakım verme sorumluluklarında güçlük; çocuğun gereksinimlerini karşılayamama, yaşa uygun beklentiler konusunda bilgi eksikliği. *Örnek:* Bebek bakımında yetersizlik; yaşlı annesine bakan kadının tükenmesi.
- **İhmal:** Çocuğun ya da bakıma muhtaç bir bireyin temel gereksinimlerinin karşılanmaması.
- **İstismar:** Fiziksel, duygusal, cinsel istismar.
- **Büyüme ve gelişme:** Yaşa göre beklenen fiziksel, motor, dil, sosyal gelişimden sapma. *Örnek:* Persentil eğrisinde düşen bebek; konuşması gecikmiş çocuk.

Fizyolojik alan (18 problem)

Yaşamı sürdüren işlevler ve süreçler.

- **İşitme:** İşitme kaybı, işitme taraması başarısızlığı.
- **Görme:** Görme bozukluğu, gözlük gereksinimi, şaşılık.
- **Konuşma ve dil:** Konuşma ve dil gelişiminde güçlük.
- **Ağız sağlığı:** Diş çürüğü, diş eti hastalığı, yetersiz ağız bakımı, protez sorunları.
- **Biliş:** Bellek, dikkat, karar verme sorunları (demans, öğrenme güçlüğü).
- **Ağrı:** Akut ya da kronik ağrı.
- **Bilinç:** Bilinç düzeyinde değişiklik.
- **Deri (cilt):** Yara, bası yarası, döküntü, kuruluk, pişik, pediküloz ve uyuzun cilt bulguları.
- **Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu:** Hareket, denge, kas gücü, eklem hareketi sorunları; düşme riski; skolyoz.
- **Solunum:** Nefes darlığı, öksürük, astım, KOAH, anormal solunum sesleri.
- **Dolaşım:** Anormal kan basıncı, ödem, göğüs ağrısı, varis, nabız düzensizliği.
- **Sindirim-hidrasyon:** Bulantı, kusma, yutma güçlüğü, sıvı alımında yetersizlik, dehidratasyon.
- **Bağırsak fonksiyonu:** Kabızlık, ishal, dışkılama alışkanlığında değişiklik.
- **Üriner fonksiyon:** İdrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu belirtileri.
- **Üreme fonksiyonu:** Adet düzensizliği, menopoz yakınmaları, üreme organlarıyla ilgili sorunlar.
- **Gebelik:** Gebeliğe bağlı sorunlar ve riskler; gebelik izlemi, gebelik yakınmaları, tehlike belirtileri.
- **Doğum sonu (postpartum):** Lohusalık dönemine ait sorunlar: emzirme güçlüğü, kanama, involüsyon, doğum sonu değişikliklerle baş etme.
- **Bulaşıcı/enfeksiyöz durum:** Enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyon riski (aşı eksikliği, el hijyeni yetersizliği, salgın).

Sağlıkla ilgili davranışlar alanı (8 problem)

Sağlığı sürdürme ve geliştirmeye yönelik davranış örüntüleri.

- **Beslenme:** Dengesiz beslenme, kilo fazlalığı ya da azlığı, önerilen diyete uymama, yaşa uygun olmayan beslenme (bebekte erken ek gıda), hiperglisemi/hipoglisemi.
- **Uyku ve dinlenme örüntüleri:** Uyku süresi ve kalitesinde sorun, yaşa uygun olmayan uyku düzeni, ekran nedeniyle geç yatma.
- **Fiziksel aktivite:** Hareketsiz yaşam, yaşa ya da sağlık durumuna uygun olmayan aktivite.
- **Kişisel bakım:** Banyo, giyinme, el yıkama, diş fırçalama, tuvalet gibi öz bakım etkinliklerinde güçlük ya da yetersizlik.
- **Madde kullanımı:** Sigara, elektronik sigara, alkol, madde kullanımı; ilacın kötüye kullanımı.
- **Aile planlaması:** Uygun yöntem kullanmama, yöntemi yanlış kullanma, yöntemlerle ilgili bilgi eksikliği.
- **Sağlık bakımı denetimi:** Sağlık hizmetlerinin uygun kullanımı: **rutin ve koruyucu sağlık bakımını (izlemler, aşılar, kanser taramaları, kontroller) almama**, tedavi planına uymama, belirtileri izlememe. *Kanser tarama eğitimlerinde en sık kullanılan problemdir.*
- **İlaç rejimi:** İlaçları önerilen doz ve zamanda kullanmama, yan etkileri tanımama, ilaçları uygun saklamama, çoklu ilaç kullanımına bağlı sorunlar.

> Problemlerin Türkçe adları, kullanılan Türkçe kaynağa göre küçük farklılıklar gösterebilir (örneğin "Sosyal temas/Sosyal ilişki", "Maneviyat/Spiritüel durum", "Sağlık bakımı denetimi/Sağlık bakımının gözetimi"). Dersinde kullanılan listeye uy.

2.2 Hangi problemi seçeceğime nasıl karar veririm?

En sık karıştırılan durumlar ve doğru seçimler:

- **Kanser taraması yaptırmayan kadın:** Sorun bir hastalık değil, koruyucu bakımı almama davranışıdır → **Sağlık bakımı denetimi.** (Meme dokusunda bir değişiklik bulunmuşsa → Üreme fonksiyonu / Deri gibi fizyolojik bir problem de eklenebilir.)
- **Tansiyonu yüksek birey:** Kan basıncı değerlerinin anormal olması → **Dolaşım.** İlacını düzensiz kullanıyorsa ayrıca **İlaç rejimi**; tuzlu besleniyorsa **Beslenme.**
- **Diyabetli birey:** Kan şekeri yüksek, diyete uymuyor → **Beslenme** (hiperglisemi belirtisi bu problemde yer alır); insülin uygulamasında hata → **İlaç rejimi**; ayakta yara → **Deri.**
- **Emzirmede güçlük yaşayan lohusa:** → **Doğum sonu.** Bebeğin kilo alamaması ayrıca bebek için **Büyüme ve gelişme** ya da **Beslenme** olarak değerlendirilebilir.
- **El yıkamayan öğrenciler:** Enfeksiyon riski → **Bulaşıcı/enfeksiyöz durum (potansiyel)**; el yıkama becerisi eksikliği → **Kişisel bakım**; okulda sabun yok → **Sanitasyon.**
- **Yaşlının düşme riski:** Denge ve yürüme sorunu → **Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu**; evdeki tehlikeler → **Konut**; çok ilaç → **İlaç rejimi.**
- **Sigara içen gebe:** → **Madde kullanımı** (+ gebeliğe etkisi açısından **Gebelik**).
- **Obez ergen:** → **Beslenme** ve **Fiziksel aktivite.**
- **Ekran nedeniyle geç yatan çocuk:** → **Uyku ve dinlenme örüntüleri.**
- **Diş fırçalamayan sınıf:** → **Ağız sağlığı** (çürük vb. varsa gerçek, yoksa potansiyel).
- **Stresli öğretmenler:** → **Ruh sağlığı**; ses kısıklığı → **Konuşma ve dil**; bel ağrısı → **Ağrı / Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu.**

Kural: Bir eğitim ya da izlem için **eğitimin odağına uygun 1–2 problem** yeterlidir. Çok sayıda ilgisiz problem yazmak kaydı karmaşıklaştırır.

2.3 Niteleyiciler (modifier)

Her problem **iki niteleyici** ile tanımlanır.

a) Kapsam niteleyicisi – Kimin problemi?

- **Birey:** Tek bir kişiye yönelik çalışıyorsan (ASM'de bireysel eğitim, bir hastanın izlemi).
- **Aile:** Sorun ailenin bütününü ilgilendiriyorsa ya da aileyle birlikte çalışıyorsan (ev ziyaretinde aileye yönelik bakım).
- **Toplum:** Bir gruba ya da topluluğa yönelik çalışıyorsan (bir sınıf, okulun tüm öğretmenleri, huzurevi sakinleri, bekleme salonundaki grup, bir mahalle).

> Sık hata: Bir sınıfa eğitim yapıp kapsamı "Birey" yazmak. Grup eğitimi **Toplum**dur.

b) Durum (önem) niteleyicisi – Problemin düzeyi ne?

- **Sağlığın geliştirilmesi:** Belirti ya da risk faktörü **yok**; kişi bilgisini, davranışını ya da sağlığını **geliştirmek istiyor**. *Örnek:* "Gebelikte nasıl beslenmem gerektiğini öğrenmek istiyorum" diyen sağlıklı gebe.
- **Potansiyel (olası):** Belirti ve bulgu **yok**, ama sorunun gelişmesine yol açabilecek **risk faktörleri var**. *Örnek:* El yıkamayan ama henüz hastalık olmayan sınıf; düşmemiş ama evinde tehlikeler bulunan yaşlı.
- **Gerçek (mevcut):** Bir ya da daha fazla **belirti/bulgu var**. *Örnek:* Kan basıncı 156/96 olan birey; meme başı çatlakları olan lohusa; taramasını yaptırmamış kadın.

2.4 Belirti/bulgular ve risk faktörleri

- **Gerçek** niteleyicisi seçildiyse, Omaha'nın o problem için verdiği listeden uygun **belirti/bulgular** seçilir ve **bireyden elde ettiğin somut verilerle** desteklenir. *Örnek (Dolaşım):* "Anormal kan basıncı değerleri – 156/96 mmHg"; "Ödem – ayak bileklerinde gode bırakan ödem".
- **Potansiyel** niteleyicisi seçildiyse **risk faktörleri** yazılır. *Örnek (Bulaşıcı/enfeksiyöz durum):* "Teneffüs sonrası ellerin yıkanmaması, lavabolarda sabun olmaması, kalabalık sınıf."
- **Sağlığın geliştirilmesi** seçildiyse kişinin **isteği/ilgisi** yazılır.

Belirti/bulgu örnekleri (problem bazında, sık kullanılanlar):

- **Sağlık bakımı denetimi:** Rutin/koruyucu sağlık bakımını almıyor (tarama, izlem, aşı yaptırmıyor); belirtileri izlemiyor; tedavi planına uymuyor; sağlık kurumuna geç başvuruyor.
- **Dolaşım:** Anormal kan basıncı değerleri; ödem; göğüs ağrısı; varis; nabız düzensizliği.
- **Beslenme:** Boya göre ağırlığın normalin üstünde/altında olması; dengesiz beslenme; önerilen beslenme planına uymama; yaşa uygun olmayan beslenme; hiperglisemi; hipoglisemi.
- **Fiziksel aktivite:** Sedanter yaşam biçimi; yetersiz ya da uygun olmayan egzersiz.
- **İlaç rejimi:** Önerilen doz/takvime uymama; yan etkileri tanımama; ilaçların uygun saklanmaması; ilaçların yetersiz sağlanması.
- **Madde kullanımı:** Sigara/tütün kullanımı; alkol kötüye kullanımı.
- **Doğum sonu:** Emzirmede güçlük; anormal kanama/akıntı; doğum sonu değişikliklerle baş etmede güçlük; duygusal sıkıntı.
- **Gebelik:** Gebelik yakınmalarıyla baş etmede güçlük; gebelik izlemine düzensiz gelme; tehlike belirtileri.
- **Ağız sağlığı:** Çürük; diş eti kanaması; ağız bakımını yetersiz yapma.
- **Kişisel bakım:** El yıkama, banyo, diş fırçalama gibi öz bakım etkinliklerinde yetersizlik.
- **Bakım verme/ebeveynlik:** Çocuğun fiziksel/duygusal gereksinimlerini karşılamada güçlük; bebek bakımı konusunda bilgi eksikliği.
- **Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu:** Denge bozukluğu; yürüme güçlüğü; kas gücünde azalma; düşme öyküsü.
- **Konut:** Kaygan halılar; yetersiz aydınlatma; güvensiz merdiven; tehlikeli maddelerin uygunsuz saklanması.

---

3. İKİNCİ BİLEŞEN: GİRİŞİM ŞEMASI

Her girişim üç parçadan oluşur: **Kategori + Hedef + Bireye özgü bilgi.**

- **Kategori:** Ne tür bir girişim? (4 kategori)
- **Hedef:** Girişimin neye odaklandığı, konusu. (75 hedef)
- **Bireye özgü bilgi:** Tam olarak ne yaptığın, kısa ve somut bir açıklama.

3.1 Dört kategori

1. Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık Bilgi verme, beceri öğretme, kişinin karar vermesine ve sorumluluk almasına yardım etme, cesaretlendirme. Eğitimlerin büyük bölümü bu kategoridedir. *Örnekler:* KKMM'yi öğretme; tuz kısıtlamasını anlatma; doğru emzirme tekniğini anlatma; sigara bırakma danışmanlığı; ek gıdaya geçişi anlatma; gebelikte tehlike belirtilerini anlatma.

2. Tedaviler ve işlemler Belirti ve bulguları önlemeye, azaltmaya ya da risk faktörlerini gidermeye yönelik **teknik hemşirelik uygulamaları**. *Örnekler:* Aşı uygulama; enjeksiyon; pansuman; kan alma; topuk kanı alma; GGT kiti verme ve numune alma; HPV-smear örneği alma; emzirme sırasında kavramayı düzeltme; el yıkamayı uygulatma.

3. Vaka yönetimi Koordinasyon, savunuculuk, yönlendirme (sevk), kaynak bulma, iletişimi kolaylaştırma. *Örnekler:* Hekime bildirme; KETEM'e mamografi randevusu alma; kolonoskopiye yönlendirme ve takip; diyetisyene, fizyoterapiste, sosyal hizmetlere yönlendirme; okul idaresiyle görüşerek lavabolara sabun konmasını sağlama; belediyeden destek isteme.

4. Gözetim (sürveyans/izlem) Bireyin durumunu ya da girişimlerin sonucunu belirli aralıklarla **ölçme, gözleme, takip etme**. *Örnekler:* Kan basıncını izleme; bebeğin kilo alımını izleme; bir ay sonra KKMM yapıp yapmadığını sorma; GGT sonucunu ve kolonoskopiye gidip gitmediğini takip etme; bir hafta sonra öğrencilerin el yıkama davranışını gözleme; ilaç uyumunu bir sonraki izlemde kontrol etme.

> Gözetim kategorisi en sık unutulan kategoridir. "Bir sonraki görüşmede neyi kontrol edeceğim?" sorusunun cevabı gözetim girişimidir ve **her kayıtta en az bir gözetim girişimi** bulunması iyi bir uygulamadır.

3.2 Hedefler – halk sağlığında sık kullanılanlar

Omaha'da toplam **75 hedef** vardır. Aşağıda halk sağlığı uygulamasında en sık kullanacağın hedefler, kısa açıklamaları ve kullanım örnekleriyle verilmiştir (parantez içinde İngilizce adları):

- **Anatomi/fizyoloji** (anatomy/physiology): Vücut yapısı ve işleyişi. *Meme yapısı, süt yapımı, menstrüel döngü.*
- **Davranış değişikliği** (behavior modification): Davranışı değiştirmeye yönelik planlar. *Sigara bırakma planı, ekran süresini azaltma.*
- **Bağlanma** (bonding/attachment): Ebeveyn-bebek bağı. *Ten tene temas, bebekle konuşma.*
- **Bakım verme/ebeveynlik becerileri** (caretaking/parenting skills): Bebek-çocuk bakımı, bakım verme. *Bebek banyosu, göbek bakımı, olumlu disiplin.*
- **Baş etme becerileri** (coping skills): Hastalık ve stresle baş etme.
- **Diyet yönetimi** (dietary management): Beslenme düzeni, besin seçimi. *Tuz kısıtlaması, diyabette beslenme, sağlıklı beslenme tabağı.*
- **Pansuman/yara bakımı** (dressing change/wound care).

- **Egzersizler** (exercises): Fiziksel aktivite ve egzersiz. *Yürüyüş programı, Kegel, denge egzersizleri.*
- **Aile planlaması bakımı** (family planning care): Yöntemler ve kullanımı.
- **Besleme işlemleri** (feeding procedures): Bebek ve çocuğun beslenme teknikleri. *Emzirme tekniği, ek gıdaya geçiş, biberon hijyeni.*
- **Büyüme/gelişim bakımı** (growth/development care): Büyüme ve gelişmeyi izleme ve destekleme. *Persentil, kilometre taşları, gelişimi destekleyen oyunlar.*
- **Enfeksiyondan korunma önlemleri** (infection precautions): *El yıkama, öksürük-hapşırık hijyeni, bulaşıcı hastalıklardan korunma.*
- **Laboratuvar bulguları** (laboratory findings): *HbA1c, hemoglobin sonuçlarının açıklanması.*
- **Tıbbi/dental bakım** (medical/dental care): Hekime ya da diş hekimine yönlendirme ve izlem. *Hipertansif hastanın hekime bildirilmesi, çürükleri olan öğrencinin diş hekimine yönlendirilmesi.*
- **İlaç etkileri/yan etkileri** (medication action/side effects): *Demirin dişleri boyayabileceği, antihipertansifin etkisi.*
- **İlaç uygulama** (medication administration): *İnsülin uygulama, inhaler kullanımı, D vitamini damlasının verilmesi.*
- **İlaç düzenleme** (medication set-up): *Haftalık ilaç kutusu hazırlama.*
- **Hareketlilik/transfer** (mobility/transfers): *Yaşlının yataktan güvenli kalkması.*
- **Diyetisyen bakımı** (nutritionist care): Diyetisyene yönlendirme.
- **Diğer toplum kaynakları** (other community resources): *KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezi, sosyal hizmetler, ALO 171.*
- **Kişisel hijyen** (personal hygiene): *Perine hijyeni, diş fırçalama, banyo, menstrüel hijyen.*
- **Gevşeme/solunum teknikleri** (relaxation/breathing techniques): *Stres yönetimi, KOAH'ta büzük dudak solunumu.*
- **Dinlenme/uyku** (rest/sleep): *Uyku hijyeni.*
- **Güvenlik** (safety): *Kaza önleme, ev güvenliği, güvenli uyku, trafik güvenliği.*
- **Tarama işlemleri** (screening procedures): *Mamografi, HPV-smear, GGT, KKMM, görme ve işitme taramaları, skolyoz taraması.*
- **Hastalık/yaralanma bakımı** (sickness/injury care): *Ateşli çocuğun evde bakımı, ishalde sıvı.*
- **Belirti/bulgular – zihinsel/duygusal** (signs/symptoms – mental/emotional): *Doğum sonu depresyon belirtileri, stres belirtileri.*
- **Belirti/bulgular – fiziksel** (signs/symptoms – physical): *Gebelikte ve lohusalıkta tehlike belirtileri, kanser uyarı belirtileri, hipoglisemi belirtileri, KB ölçümü.*
- **Cilt bakımı** (skin care): *Bası yarası önleme, pişik, meme başı bakımı.*
- **Örnek (numune) toplama** (specimen collection): *GGT numunesi, idrar örneği, topuk kanı.*
- **Uyarılma/besleyici bakım** (stimulation/nurturance): *Bebeğin gelişimini uyaran oyun, konuşma, kitap okuma.*
- **Stres yönetimi** (stress management).
- **Madde kullanımını bırakma** (substance use cessation): *Sigara bırakma.*
- **Malzemeler** (supplies): *Sabun, kâğıt havlu, gece lambası gibi gerekli malzemelerin sağlanması.*
- **Destek grubu / Destek sistemi** (support group / support system): *Emzirme destek grubu, aile ve komşu desteği.*
- **Ulaşım** (transportation): *Taramaya gidemeyen yaşlı için ulaşım desteği.*
- **İyilik hali** (wellness): *Genel sağlıklı yaşam davranışları.*

3.3 Bireye özgü bilgi

Kategori ve hedef seçtikten sonra **tam olarak ne yaptığını** kısa ve somut yazarsın. Örneğin:

- Eksik yazım: "Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – Diyet yönetimi."
- Tam yazım: "Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – Diyet yönetimi – **Günlük tuz sınırı (<5 g), gizli tuz kaynakları ve tuzu azaltma yolları, 5 g tuz çay kaşığıyla gösterilerek bireye ve eşine anlatıldı.**"

---

4. ÜÇÜNCÜ BİLEŞEN: PROBLEM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Her problem **üç boyutta**, **1'den 5'e** kadar puanlanır. **1 en olumsuz, 5 en olumlu** durumdur.

4.1 Bilgi

Tanım: Bireyin bilgiyi hatırlama ve yorumlama yeteneği – "Ne biliyor?"

- **1 – Bilgisi yok**
- **2 – Az (minimal) bilgi**
- **3 – Temel bilgi**
- **4 – Yeterli bilgi**
- **5 – Üstün (çok iyi) bilgi**

Nasıl puanlarım? Ön test–son test, soru-cevap ya da kişinin anlattıklarına göre. *Örnek:* Kanser taramasıyla ilgili 5 sorudan eğitim öncesi 1'ini doğru cevapladı → **2**; eğitim sonrası 4'ünü doğru cevapladı → **4**; 5'ini de doğru cevapladı ve ek sorular sordu → **5**.

4.2 Davranış

Tanım: Bireyin duruma ya da amaca uygun, gözlenebilir yanıtları, eylemleri ve etkinlikleri – "Ne yapıyor?"

- **1 – Hiç uygun değil**
- **2 – Nadiren uygun**
- **3 – Tutarsız (bazen uygun)**
- **4 – Genellikle uygun**
- **5 – Sürekli (her zaman) uygun**

Nasıl puanlarım? Gözlem (geri gösterim, uygulama) ya da kişinin beyanı ve kayıtlarla. *Örnek:* Hiç KKMM yapmamış, hiç mamografi çektirmemiş → **1**; eğitimde KKMM'yi maket üzerinde doğru gösterdi ve mamografi randevusu aldı ama henüz düzenli uygulamıyor → **3**; bir sonraki izlemde iki aydır düzenli KKMM yaptığını ve mamografi çektirdiğini belirtti → **4–5**.

> Davranış gerçek anlamda zamanla değişir. Tek oturumluk bir eğitimde son davranış puanını eğitim sırasındaki uygulamaya (geri gösterim) ve kişinin somut adımlarına (randevu alması, kiti alması) göre verirsin; gerçek davranışı **bir sonraki görüşmede** kontrol edersin (gözetim girişimi).

4.3 Durum

Tanım: Bireyin, problemin belirti ve bulguları açısından içinde bulunduğu hal – "Sorun ne kadar ağır?"

- **1 – Aşırı (çok ciddi) belirti/bulgu**
- **2 – Ciddi belirti/bulgu**
- **3 – Orta düzeyde belirti/bulgu**
- **4 – Az (minimal) belirti/bulgu**
- **5 – Belirti/bulgu yok**

Nasıl puanlarım? Ölçümler ve gözlemlere göre. *Örnek (Dolaşım):* KB 185/115 → **1**; 165/100 → **2**; 148/94 → **3**; 136/86 → **4**; 122/78 → **5**. *Örnek (Doğum sonu):* Her iki meme başında derin çatlak, şiddetli ağrı → **2**; çatlaklar iyileşmede, ağrı azaldı → **3–4**; sorun yok → **5**.

Potansiyel ve sağlığın geliştirilmesi problemlerinde belirti olmadığından durum puanı genellikle yüksektir (4–5); bu normaldir.

4.4 Ne zaman puanlanır?

- **Başlangıç (kabul) puanı:** İlk görüşmede, eğitim ya da girişimden **önce**.
- **Ara değerlendirme:** İzlem sürecinde gerektiğinde.
- **Son (taburculuk) puanı:** Eğitimin sonunda, bir sonraki ziyarette ya da bakım bittiğinde.
- İstenirse **hedef (beklenen) puan** da yazılır.

Başlangıç ve son puanlar arasındaki fark, **eğitimin ve bakımın etkisini** gösterir; formdaki "problemin değerlendirilmesi" kısmı budur. **Her puanın neye dayanarak verildiğini** (ön-son test, geri gösterim, ölçüm) kısaca yazmak kaydı güçlendirir.

---

5. ADIM ADIM OMAHA KAYDI NASIL YAPILIR?

1. **Veriyi topla:** Bireyle görüş, gözlemle, ölç (eğitim öncesi ön test dahil).
2. **Alanı seç:** Sorun çevresel mi, psikososyal mi, fizyolojik mi, sağlıkla ilgili davranış mı?
3. **Problemi seç:** O alandaki 42 problemden en uygun olanı.
4. **Kapsamı belirle:** Birey / Aile / Toplum.
5. **Durumu belirle:** Sağlığın geliştirilmesi / Potansiyel / Gerçek.
6. **Belirti/bulguları (gerçek) ya da risk faktörlerini (potansiyel) yaz:** Somut verilerle.
7. **Başlangıç puanlarını ver:** Bilgi, Davranış, Durum (gerekçesiyle).
8. **Girişimleri yaz:** Her girişim için kategori + hedef + bireye özgü bilgi. Mümkünse dört kategorinin her birinden en az bir girişim düşün; özellikle **gözetimi** unutma.
9. **Girişimleri uygula.**
10. **Son puanları ver:** Eğitim sonunda ya da bir sonraki görüşmede; değişimi yorumla.
11. **Gerekirse planı güncelle** (yeni girişim, yeni izlem tarihi).

Kayıt iskeleti (her eğitim/izlem için):

- Tarih, yer (ASM/okul/kurum), birey ya da grup (baş harfler, yaş, cinsiyet ya da grup tanımı)
- **Problem:** Alan – Problem – Kapsam – Durum – Belirti/bulgular ya da risk faktörleri
- **Girişimler:** Kategori – Hedef – Bireye özgü bilgi (her girişim ayrı satırda)
- **Problem değerlendirme ölçeği:** Bilgi (başlangıç → son), Davranış (başlangıç → son), Durum (başlangıç → son), gerekçe

---

6. DOLDURULMUŞ ÖRNEKLER

6.1 ASM – Kanser tarama eğitimi (KKMM ve mamografi)

Birey: A.Y., 46 yaşında kadın. Hiç KKMM yapmamış, hiç mamografi çektirmemiş; "Bende bir şikâyet yok, gerek yok" diyor. Annesinde 58 yaşında meme kanseri öyküsü var.

Problem: Sağlıkla ilgili davranışlar alanı – **Sağlık bakımı denetimi** – Birey – **Gerçek**

- Belirti/bulgular: Rutin/koruyucu sağlık bakımını almıyor (46 yaşında hiç mamografi çektirmemiş); KKMM yapmıyor; taramayla ilgili yanlış inanç ("Şikâyet yoksa gerek yok").

Başlangıç puanları: Bilgi **2** (5 soruluk ön testte 1 doğru) · Davranış **1** (hiç tarama ve KKMM yok) · Durum **3** (taraması eksik, risk faktörü var)

Girişimler:

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Tarama işlemleri** – Ulusal meme kanseri taraması (40–69 yaş, 2 yılda bir mamografi), KKMM'nin zamanı ve basamakları meme maketi üzerinde gösterildi, kendisine uygulatıldı.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Belirti/bulgular – fiziksel** – Meme kanserinin uyarı belirtileri ve bir değişiklik fark ettiğinde beklemeden başvurması gerektiği anlatıldı.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Anatomi/fizyoloji** – Meme yapısı ve kadranları, kanserlerin en sık üst-dış bölgede görüldüğü anlatıldı.
- Vaka yönetimi – **Diğer toplum kaynakları** – KETEM'den mamografi randevusu alındı; aile öyküsü nedeniyle hekime bilgi verildi.
- Gözetim – **Tarama işlemleri** – Bir ay sonra telefonla KKMM yapıp yapmadığı ve mamografinin çekilip çekilmediği sorulacak; sonuç takip edilecek.

Son puanlar: Bilgi **4** (son testte 4/5 doğru) · Davranış **3** (KKMM'yi maket üzerinde 8 basamağın 7'sini doğru gösterdi, randevu aldı; düzenli uygulama henüz yok) · Durum **4** (taramaya yönlendirildi) · Hedef: B5 – D5 – D5

6.2 ASM – Hipertansiyonu olan yetişkin

Birey: M.K., 58 yaşında erkek; KB 156/96 mmHg; ilacını "kendini iyi hissedince" bırakıyor; yemeğe tadına bakmadan tuz ekliyor, her öğün turşu yiyor.

Problem 1: Fizyolojik alan – **Dolaşım** – Birey – Gerçek. Belirti: Anormal kan basıncı değerleri (156/96 mmHg). **Problem 2:** Sağlıkla ilgili davranışlar – **İlaç rejimi** – Birey – Gerçek. Belirti: Önerilen ilaç takvimine uymuyor. **Problem 3:** Sağlıkla ilgili davranışlar – **Beslenme** – Birey – Gerçek. Belirti: Önerilen beslenme planına (tuz kısıtlaması) uymuyor.

Başlangıç puanları (Problem 1): Bilgi 2 · Davranış 2 · Durum 2

Girişimler:

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Diyet yönetimi** – Günlük tuz sınırı, gizli tuz kaynakları, tuzu azaltma yolları bireye ve eşine anlatıldı.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **İlaç etkileri/yan etkileri** – İlacın kendini iyi hissetse de düzenli alınması gerektiği açıklandı.

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **İlaç düzenleme** – Haftalık ilaç kutusu birlikte dolduruldu, telefon alarmı kuruldu.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Belirti/bulgular – fiziksel** – Hipertansif acil belirtileri ve 112 anlatıldı.
- Tedaviler ve işlemler – **Belirti/bulgular – fiziksel** – Doğru teknikle iki kez KB ölçüldü.
- Vaka yönetimi – **Tıbbi/dental bakım** – Değerler hekime bildirildi.
- Vaka yönetimi – **Diyetisyen bakımı** – Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyenine yönlendirildi.
- Gözetim – **Belirti/bulgular – fiziksel** – İki hafta sonra KB ve ilaç kutusu kontrolü.

Son puanlar (Problem 1, iki hafta sonra): Bilgi 4 · Davranış 3 (14 günün 11'inde ilaç almış, turşuyu azaltmış) · Durum 3 (KB 146/92)

6.3 Okul – İlkokul sınıfında el hijyeni (toplum düzeyi)

Grup: 2-B sınıfı, 28 öğrenci. Gözlemde teneffüs sonrası öğrencilerin çoğu ellerini yıkamadan beslenmesini yiyor; tuvalet lavabolarında sabun yok; son iki haftada 6 öğrenci ishal ve soğuk algınlığı nedeniyle devamsızlık yapmış.

Problem 1: Fizyolojik alan – **Bulaşıcı/enfeksiyöz durum** – **Toplum** – **Potansiyel**. Risk faktörleri: Yetersiz el hijyeni, kalabalık sınıf, lavabolarda sabun bulunmaması. **Problem 2:** Çevresel alan – **Sanitasyon** – Toplum (okul) – Gerçek. Belirti: Tuvalet lavabolarında sabun ve kâğıt havlu yok.

Başlangıç puanları (Problem 1): Bilgi 2 (öğrencilerin çoğu el yıkama zamanlarını sayamadı) · Davranış 2 (yemekten önce el yıkayan öğrenci çok az) · Durum 3

Girişimler:

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Enfeksiyondan korunma önlemleri** – Mikropların nasıl bulaştığı, el yıkamanın dört kritik zamanı kukla gösterisiyle anlatıldı.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Kişisel hijyen** – Yedi adımda el yıkama, 20 saniyelik şarkı eşliğinde gösterildi.
- Tedaviler ve işlemler – **Enfeksiyondan korunma önlemleri** – Her öğrenciye lavaboda uygulamalı el yıkama yaptırıldı.
- Vaka yönetimi – **Malzemeler** – Okul idaresiyle görüşüldü; lavabolara sıvı sabun ve kâğıt havlu konması sağlandı.
- Gözetim – **Enfeksiyondan korunma önlemleri** – Bir hafta sonra teneffüs sonrası el yıkama davranışı gözlenecek; devamsızlık sayısı izlenecek.

Son puanlar (Problem 1): Bilgi 4 · Davranış 4 (28 öğrencinin 24'ü yedi adımı doğru uyguladı) · Durum 4. *(Problem 2 – Sanitasyon: Durum 2 → 5, sabun sağlandı.)*

6.4 Lohusa izlemi – Emzirmede güçlük

Birey: Z.T., 24 yaşında, ilk doğum, doğum sonu 6. gün. Meme başlarında çatlak ve ağrı; bebek yalnızca meme başını kavrıyor; "Sütüm yetmiyor" diyerek iki gündür mama ekliyor.

Problem: Fizyolojik alan – **Doğum sonu** – Birey – Gerçek. Belirti/bulgular: Emzirmede güçlük, meme başı çatlakları, ağrı.

Başlangıç puanları: Bilgi 2 · Davranış 2 · Durum 2

Girişimler:

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Besleme işlemleri** – Doğru tutuş ve kavramanın belirtileri anlatıldı.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Anatomi/fizyoloji** – Süt yapımının arz-talep ilkesi ve yeterli süt belirtileri anlatıldı.
- Tedaviler ve işlemler – **Besleme işlemleri** – Emzirme sırasında kavrama düzeltildi.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Cilt bakımı** – Emzirme sonrası sütün meme başına sürülüp kurutulması önerildi.
- Vaka yönetimi – **Destek grubu** – Emzirme danışmanı/destek grubu bilgisi verildi.
- Gözetim – **Büyüme/gelişim bakımı** – Bebeğin ağırlığı 3 gün sonra ve 15. gün izleminde kontrol edilecek.

Son puanlar (15. gün): Bilgi 4 · Davranış 4 (doğru kavramanın dört belirtisi gözlendi, mamayı bıraktı) · Durum 4 (çatlaklar iyileşti, bebek doğum ağırlığını geçti)

6.5 Ev ziyareti – Yaşlıda düşme riski

Birey: H.D., 78 yaşında, yalnız yaşıyor; son 6 ayda bir kez düşmüş; Kalk ve Yürü testi 16 sn; evde kaygan halılar, koridorda aydınlatma yok; 6 ilaç kullanıyor.

Problem 1: Fizyolojik – **Nöro-müsküler-iskelet fonksiyonu** – Birey – Gerçek. Belirti: Denge bozukluğu, yürüme güçlüğü, düşme öyküsü. **Problem 2:** Çevresel – **Konut** – Birey – Gerçek. Belirti: Kaygan halılar, yetersiz aydınlatma, banyoda tutunma barı yok. **Problem 3:** Sağlıkla ilgili davranışlar – **İlaç rejimi** – Birey – Potansiyel. Risk faktörü: 6 ilaç kullanımı (biri uyku ilacı).

Başlangıç puanları (Problem 2): Bilgi 2 · Davranış 1 · Durum 2

Girişimler:

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Güvenlik** – Ev güvenliği kontrol listesiyle evdeki tehlikeler ve önlemleri birlikte belirlendi.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Hareketlilik/transfer** – Yataktan güvenli kalkma öğretildi ve uygulatıldı.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Egzersizler** – Denge ve kuvvet egzersizleri gösterildi.
- Vaka yönetimi – **Tıbbi/dental bakım** – Polifarmasi açısından hekime bildirildi.
- Vaka yönetimi – **Malzemeler / Diğer toplum kaynakları** – Tutunma barı ve gece lambası için kızı ve belediye sosyal hizmetleriyle iletişim kuruldu.
- Gözetim – **Güvenlik** – İki hafta sonra ev ziyaretinde düzenlemeler kontrol edilecek.

Son puanlar (Problem 2, iki hafta sonra): Bilgi 4 · Davranış 3 (halıları kaldırdı, gece lambası henüz yok) · Durum 3

6.6 ASM – Sigara içen gebe

Birey: E.K., 29 yaşında, 16 haftalık gebe, günde 10 sigara içiyor; "Birden bırakırsam bebeğe stres olur diye duydum" diyor.

Problem 1: Sağlıkla ilgili davranışlar – **Madde kullanımı** – Birey – Gerçek. Belirti: Gebelikte günde 10 sigara kullanımı. **Problem 2:** Fizyolojik – **Gebelik** – Birey – Potansiyel. Risk faktörü: Gebelikte sigara kullanımı (düşük doğum ağırlığı, erken doğum riski).

Başlangıç puanları (Problem 1): Bilgi 2 · Davranış 1 · Durum 2

Girişimler:

- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Madde kullanımını bırakma** – Gebelikte sigaranın bebeğe etkileri ve bırakmanın her dönemde yararlı olduğu anlatıldı; "bırakmak bebeğe stres yapar" inancı düzeltildi.
- Sağlık eğitimi, rehberlik ve danışmanlık – **Davranış değişikliği** – Bırakma tarihi birlikte belirlendi, tetikleyicilerle baş etme yolları konuşuldu.
- Vaka yönetimi – **Diğer toplum kaynakları** – ALO 171 ve sigara bırakma polikliniği bilgisi verildi; hekime bildirildi.
- Gözetim – **Madde kullanımını bırakma** – Bir sonraki gebe izleminde günlük sigara sayısı sorulacak.

Son puanlar (bir sonraki izlem): Bilgi 4 · Davranış 3 (günde 3 sigaraya indirdi) · Durum 3

6.7 Okul – Öğretmenlerde ses sağlığı ve stres (toplum düzeyi)

Grup: Okulun 22 öğretmeni. Ankette 13 öğretmen sık ses kısıklığı, 15 öğretmen yoğun stres bildirdi.

Problem 1: Fizyolojik – **Konuşma ve dil** – Toplum – Gerçek. Belirti: Öğretmenlerin yarıdan fazlasında sık ses kısıklığı.
Problem 2: Psikososyal – **Ruh sağlığı** – Toplum – Gerçek. Belirti: Öğretmenlerin çoğunda yoğun stres bildirimi.

Girişimler: Sağlık eğitimi – **Kişisel hijyen** (ses hijyeni: bol su, bağırmama, sınıfı sessizleştirme teknikleri) ve **Stres yönetimi** (gevşeme ve nefes egzersizleri uygulamalı); Tedaviler ve işlemler – **Gevşeme/solunum teknikleri** (grup halinde uygulandı); Vaka yönetimi – **Tıbbi bakım** (ses kısıklığı üç haftadan uzun sürenlerin KBB'ye yönlendirilmesi); Gözetim – **Belirti/bulgular – zihinsel/duygusal** (bir ay sonra kısa anketle yeniden değerlendirme).

Puanlar (grup ortalaması): Bilgi 2 → 4 · Davranış 2 → 3 · Durum 3 → 3 (değişim zaman alacak; bir ay sonra yeniden puanlanacak)

---

7. SIK YAPILAN OMAHA HATALARI

1. **Problem yerine tıbbi tanı yazmak:** "Problem: Hipertansiyon" yanlıştır. Doğrusu: "Dolaşım – Gerçek – anormal kan basıncı değerleri".
2. **Alanı problem sanmak:** "Problem: Fizyolojik" yanlıştır. Fizyolojik bir alandır; problem "Solunum", "Dolaşım" gibi olmalıdır.
3. **Kapsamı yanlış seçmek:** Sınıfa verilen eğitimi "Birey" olarak kaydetmek. Grup eğitimi "Toplum"dur.
4. **"Gerçek" yazıp belirti/bulgu yazmamak**, "Potansiyel" yazıp risk faktörü yazmamak.
5. **Belirti/bulguyu somut veriyle desteklememek:** "Anormal kan basıncı" yazıp değeri yazmamak.
6. **Kategori yazıp hedef yazmamak:** "Sağlık eğitimi verildi" eksiktir. Kategori + hedef + bireye özgü bilgi yazılmalıdır.
7. **Hedefi yanlış seçmek:** Mamografi yönlendirmesini "Tıbbi/dental bakım" yerine "Diğer toplum kaynakları" (KETEM) olarak yazmak daha doğrudur; tarama eğitiminde "Tarama işlemleri" hedefi kullanılır.
8. **Gözetim kategorisini unutmak.**
9. **Puanları gerekçesiz vermek:** Bilgi puanının ön-son teste, davranış puanının gözleme, durum puanının ölçüme dayandığı yazılmalıdır.
10. **Yalnızca başlangıç ya da yalnızca son puanı yazmak:** Değişimi göstermek için ikisi de gerekir.
11. **Durum puanıyla bilgi puanını karıştırmak:** Bilgi "ne biliyor", davranış "ne yapıyor", durum "sorun ne kadar ağır" sorusunun cevabıdır.
12. **Tek bir eğitim için gereksiz çok problem yazmak.**

---

8. OMAHA İLE NANDA ARASINDAKİ FARK

İki sistem birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır; dersinde ikisini de kullanman beklenebilir:

- **NANDA-I** yalnızca **tanıları** sınıflar; girişim (NIC) ve sonuç (NOC) için ayrı sınıflamalar gerekir. Omaha ise **problem, girişim ve sonucu tek bir sistemde** bir arada sunar.
- NANDA tanıları daha çok **birey** odaklıdır (bazı aile ve toplum tanıları vardır); Omaha birey, aile ve toplum için **aynı yapıyı** kullanır.
- Omaha, **halk sağlığı ve ev ziyaretleri** için geliştirildiğinden çevresel sorunları (gelir, konut, sanitasyon) daha belirgin biçimde ele alır.
- Omaha'nın Bilgi-Davranış-Durum puanlaması, özellikle **sağlık eğitiminin etkisini sayısal olarak göstermek** için uygundur; bu yüzden formlarda eğitimlerin Omaha ile kaydedilmesi istenir.

Pratikte: Bakım planını (FR.185 hemşirelik süreci) NANDA ile, **her eğitim ve izlemin kaydını Omaha ile** yaparsın. Aynı bireyde ikisini birlikte de kullanabilirsin: "Etkisiz sağlık yönetimi" (NANDA) ↔ "Sağlık bakımı denetimi / İlaç rejimi" (Omaha).

---

9. KENDİNİ TEST ET

1. Omaha sisteminin üç bileşeni nedir? Her biri hemşirelik sürecinin hangi basamağına karşılık gelir?
2. Dört alanın adları ve problem sayıları nelerdir?
3. Her alandan üçer problem say.
4. Kapsam ve durum niteleyicileri nelerdir? "Potansiyel" seçtiğinde ne yazarsın? "Gerçek" seçtiğinde ne yazarsın?
5. Kanser taraması yaptırmayan bir kadın için hangi problemi seçersin? Neden?
6. Girişim şemasının dört kategorisini birer örnekle açıkla.
7. Bir girişimin üç parçası nedir? Eksik ve tam yazılmış bir girişim örneği ver.
8. Halk sağlığında sık kullanılan on hedef say.
9. Bilgi, Davranış ve Durum ölçeklerinde 1 ve 5 ne anlama gelir?
10. Bir eğitimin bilgi puanını nasıl belirlersin? Davranış puanını nasıl belirlersin?
11. Puanlama ne zamanlarda yapılır?
12. Bir sınıfa diş fırçalama eğitimi verdin. Omaha kaydını yaz. *(İpucu: Fizyolojik – Ağız sağlığı – Toplum; hedefler: Kişisel hijyen, Tıbbi/dental bakım; gözetim: bir ay sonra diş fırçalama alışkanlığı)*
13. Ergen bir öğrenciye ekran süresi ve uyku eğitimi verdin. Omaha kaydını yaz. *(İpucu: Uyku ve dinlenme örüntüleri / Fiziksel aktivite)*
14. GGT kitini verdiğin 55 yaşındaki erkek için Omaha kaydını yaz. *(İpucu: Sağlık bakımı denetimi; Tarama işlemleri, Örnek toplama, Gözetim – Tarama işlemleri)*
15. Omaha ile NANDA arasındaki üç farkı söyle.